

DIARREA DEL VIAJERO

Helmuth Guillen Zabala, Daniela Alejandra Gil Loayza.

INTRODUCCIÓN

La diarrea del viajero se define como la presencia de tres o más deposiciones de consistencia disminuida al día, comenzando durante o poco después del regreso de un viaje al extranjero. Entre los viajeros a esas áreas, 40 a 60 por ciento desarrollan diarrea (1). Generalmente se acompaña de náuseas y vómitos y, con menos frecuencia, de dolor abdominal, fiebre, tenesmo y sangre o moco en las heces. Habitualmente son cuadros agudos y autolimitados, aunque en ocasiones aparecen complicaciones tardías, como artritis reactiva, diarrea crónica, síndrome de intestino irritable posinfeccioso y síndrome de Guillain-Barré.

Los cuadros agudos autolimitados sugieren etiología bacteriana o vírica, mientras que la diarrea crónica suele implicar etiología parasitaria o diagnósticos no infecciosos como intolerancia a la lactosa o intestino irritable.

Se considera la enfermedad más común en personas que viajan desde regiones del mundo más industrializadas a países en vías de desarrollo.

Clínicamente, la gravedad de la diarrea del viajero se puede clasificar en (Tabla 1):

GRAVEDAD	CARACTERÍSTICAS
Leve	Diarrea tolerable, no es molesta y no interfiere con las actividades planificadas.
Moderada	Diarrea que causa angustia o que interfiere con las actividades planificadas.
Grave	Diarrea que incapacita o impide por completo las actividades planificadas. Toda disentería se considera grave.

DIAGNÓSTICO

Ante la aparición de un paciente con un cuadro de diarrea del viajero debe realizarse, en primer lugar, una valoración clínica que permita determinar las características del cuadro (diarrea acuosa o inflamatoria, presencia de fiebre y otros síntomas) y orientar el diagnóstico etiológico. Es importante conocer las características del viaje (destino, duración, cumplimiento de las medidas de prevención). Aunque la mayoría de los casos de diarrea del viajero están provocados por bacterias, hay otros microorganismos que también pueden producirla, variando la etiología según el destino del viajero (2)(3).

MICROORGANISMO	FRECUENCIA ESTIMADA (%)			
	Latinoamérica y Caribe	África	India	Sudeste de Asia
<i>Escherichia coli</i> enterotoxigénica	≥ 35	25-35	15-25	5-15
<i>Escherichia coli</i> enteroagregativa	25-35	< 5	15-25	-
<i>Campylobacter</i>	< 5	< 5	15-25	25-35
<i>Salmonella</i>	< 5	5-15	< 5	5-15
<i>Shigella</i>	5-15	5-15	5-15	< 5
<i>Aeromonas/Plesiomonas</i>	1-5	3-9	10	1-57
<i>Vibrios</i>	-	-	10	-
Norovirus	15-25	15-25	5-15	< 5
Rotavirus	15-25	5-15	5-15	< 5
Parásitos	4	4	10	5-15
Desconocido	44	44	38	40

Tabla 2: Diferencias geográficas en la etiología de la diarrea del viajero (modificado de Galán SF, De la Rubia F, Caro GN, Rodríguez IM. Protocolo diagnóstico y terapéutico de la diarrea del viajero. *Medicine*. 2016;12:380-386)

Clínica: Los síntomas de la diarrea del viajero dependen de la etiología microbiana. El cuadro

clínico clásico debido a *Escherichia coli* enterotoxigénica generalmente produce malestar general, anorexia y dolor abdominal tipo cólico, seguidos por la aparición aguda de diarrea acuosa. También pueden acompañarse de náuseas y vómitos. Por lo general, no hay síntomas de colitis como sangre o pus en las heces. Los pacientes pueden desarrollar una fiebre de bajo grado.

Las infecciones por otros agentes bacterianos como *Campylobacter jejuni* y *Shigella* spp, pueden progresar e incluir síntomas de colitis, como fiebre, tenesmo, urgencia, cólicos y diarrea con sangre.

Pacientes con diarrea persistente (duración >10-14 días) o que no mejora con el tratamiento antibiótico, valorar la posibilidad de patógenos menos frecuentes, resistencia antibiótica, síndrome de intestino irritable postinfeccioso o causa no infecciosa que previamente no ha sido diagnosticada.

Pruebas complementarias: Como pruebas complementarias solicitar hemograma, función renal, hepática y reactantes de fase aguda, además de coprocultivo. Si estuviera disponible, la visualización microscópica de las heces en fresco permite observar la presencia de leucocitos y hematíes, aunque no son específicos de infección y, en algunos casos, de trofozoítos, si estos son muy abundantes y las heces se examinan rápidamente tras su evacuación, además de la determinación de Rotavirus mediante inmunocromatografía.

Se aconsejaría en los viajeros que han tomado antibióticos en las últimas 8 a 12 semanas, por el riesgo de diarrea asociada a *Clostridium difficile*, someterse a una prueba para detectar este patógeno.

En pacientes que presenten signos de enfermedad sistémica, se deben realizar hemocultivos para evaluar la presencia de especies de *Salmonella* (incluida *Salmonella typhi*).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

SUEROTERAPIA: La terapia de reposición de líquidos es un componente esencial del tratamiento para todos los casos de diarrea del viajero. La mayoría de los casos son autolimitados y se resuelven por sí solos dentro de los tres a cinco días de tratamiento solo con rehidratación oral.

ANTIBIOTERAPIA: Los antibióticos y los agentes antimotilidad, que a menudo se usan juntos, pueden estar justificados en circunstancias específicas. La terapia antimicrobiana acorta la duración de la diarrea a uno o dos días y los agentes antimotilidad pueden limitar los síntomas a un período de horas. La elección de antimicrobianos depende, en parte, de la región de viaje. El beneficio de los antibióticos debe valorarse frente a los riesgos potenciales, incluidos los efectos adversos y la selección de bacterias resistentes (4).

Casos leves: el factor clave es el uso de líquidos por vía oral (hidratación con líquidos que contengan sal y azúcar de forma alterna), que no necesariamente requieren ser sueros de rehidratación oral (5). Se puede asociar con antidiarreicos como loperamida.

Casos graves: sueros de rehidratación oral, para reemplazar los electrolitos necesarios en las concentraciones adecuadas, siempre y cuando se tenga la vía oral conservada, si no, utilizar hidratación intravenosa y antieméticos. Valorar antibioterapia.

ANTIBIÓTICO	DOSIS	DURACIÓN	COMENTARIO
Azitromicina	1000 mg una vez	Dosis única*	- Preferido para la disentería o diarrea febril, viajeros del sudeste asiático y mujeres embarazadas. - La dosis de 1000 mg puede asociarse con náuseas.
	500 mg una vez al día	Curso de tres días	
Rifaximina	200 mg tres veces al día	Curso de tres días	No debe utilizarse con disentería o diarrea febril.
Levofloxacin	500 mg una vez al día	Dosis única * o curso de tres días.	Las fluoroquinolonas se asocian con múltiples eventos adversos. Resistencias en el sudeste y sur de Asia.
Ciprofloxacino	750 mg una vez	Dosis única*	
	500 mg dos veces al día	Curso de tres días	
Ofloxacin	400 mg una vez al día	Dosis única * o curso de tres días.	

* si los síntomas no se han resuelto después de 24 horas, la pauta puede extenderse hasta completar tres días.

Tabla 3: Recomendaciones de tratamiento antibiótico en diarrea del viajero (modificado de Riddle MS, Connor BA, Beeching NJ, et al. Guidelines for the prevention and treatment of travelers' diarrhea: a graded expert panel report. J Travel Med 2017; 24:S57)

La recomendación general es de no tratar con antibióticos la mayoría de los casos de diarrea del viajero, sería razonable utilizarlos en los casos severos, caracterizados por fiebre, o presencia de sangre, pus o moco en las heces, o para viajeros donde la diarrea interfiere de forma sustancial el plan de viaje. Las fluoroquinolonas con la evidencia actual, quedarían rezagadas como última opción antibiótica.

- **Alerta:** El desarrollo de disentería y/o deshidratación severa con shock inminente, justifica la hospitalización inmediata para un adecuado tratamiento y rehidratación.
- **Alerta:** Las dosis únicas de azitromicina, levofloxacin y rifaximina con loperamida fueron comparables para el tratamiento de la diarrea acuosa aguda en un ensayo clínico (6).

BIBLIOGRAFÍA

- Regina LR, Jason BH. Travelers' diarrhea: Clinical manifestations, diagnosis, and treatment. UpToDate; Topic 99648 Versión 12.0; Apr, 2018.
- Steffen R, Hill DR, DuPont HL. Traveler's diarrhea: a clinical review. JAMA. 6 de enero de 2015;313(1):71-80.
- Zaidi D, Wine E. An update on travelers' diarrhea. Curr Opin Gastroenterol. enero de 2015;31(1):7-13.
- Riddle MS, Connor BA, Beeching NJ, DuPont HL, Hamer DH, Kozarsky P, et al. Guidelines for the prevention and treatment of travelers' diarrhea: a graded expert panel report. J Travel Med. 29 de abril de 2017;24(Suppl 1):S63-80.
- Caeiro JP, DuPont HL, Albrecht H, Ericsson CD. Oral rehydration therapy plus loperamide versus loperamide alone in the treatment of traveler's diarrhea. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. junio de 1999;28(6):1286-9.
- Riddle MS, Connor P, Fraser J, Porter CK, Swierczewski B, Hutley EJ, et al. Trial Evaluating Ambulatory Therapy of Travelers' Diarrhea (TrEAT TD) Study: A Randomized Controlled Trial Comparing 3 Single-Dose Antibiotic Regimens With Loperamide. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. 29 de noviembre de 2017;65(12):2008-17.
- Galán SF, De la Rubia F, Caro GN, Rodríguez IM. Protocolo diagnóstico y terapéutico de la diarrea del viajero. Medicine. 2016;12 (7):380-386.

- Hernández TA, García VE, Moral EE, Herrero MJ, Gómez GJ, Segovia HM. Protocolo de prevención y tratamiento de la diarrea del viajero. Medicine. 2018;12(58):3425-7.